

Apostila Premium - Saúde Pública e SUS

Arquivo-fonte: apostilas/saude_basicos/saude_publica_sus.md

Apostila Premium - Saúde Pública e SUS

Concurso: Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte/ES

Edital: nº 001/2026, consolidado com as retificações nº 001/2026 e nº 002/2026

Público-alvo: cargos de nível superior da área da saúde para os quais o item 12.1 prevê Saúde Pública

Finalidade: material-base de estudo, com explicação progressiva e foco em prova objetiva

Como usar esta apostila

O Anexo II do edital delimitou os assuntos cobrados. Este caderno segue essa ordem e não acrescenta disciplinas estranhas ao programa. A proposta é ensinar cada conceito antes de pedir sua memorização. Ao final de cada capítulo, responda às questões sem consultar a teoria e registre os erros.

Referências oficiais centrais

- Constituição Federal de 1988, arts. 196 a 200.
- Lei Federal nº 8.080/1990.
- Lei Federal nº 8.142/1990.
- Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela Portaria nº 2.436/2017.
- Edital nº 001/2026 consolidado, Anexo II.

Rastreabilidade dos eixos cobrados

Eixo	Onde estudar
Constituição e direito à saúde	Capítulo 1
Lei nº 8.080/1990	Capítulos 2 e 24
Lei nº 8.142/1990 e controle social	Capítulo 3
Organização, rede e níveis de atenção	Capítulos 4, 17 e 20
APS, PNAB e ESF	Capítulos 5 e 25
Vigilância em saúde	Capítulos 6, 12 e 18
Epidemiologia e indicadores	Capítulos 7 e 11
Promoção e prevenção	Capítulos 8 e 15
Humanização e acolhimento	Capítulos 9 e 16
Determinantes, planejamento e financiamento	Capítulos 10, 19 e 23
Imunização	Capítulo 13
Articulação interfederativa e Pacto	Capítulos 14 e 17
Casos e questões integradas	Capítulos 21, 22 e 26

Capítulo 1 - Constituição Federal: seguridade social e direito à saúde

1. Introdução

O SUS não nasceu apenas como uma rede de unidades de saúde. Ele é consequência de uma escolha constitucional: no Brasil, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Para a prova, esse ponto é o alicerce dos demais temas.

2. Seguridade social

A seguridade social é o conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade destinado a assegurar direitos relativos à **saúde**, à **previdência** e à **assistência social**. As três áreas se relacionam, mas não são sinônimas.

Área	Ideia central
Saúde	Direito de todos; não depende de contribuição prévia
Previdência social	Proteção contributiva, conforme regras próprias
Assistência social	Proteção a quem dela necessitar, independentemente de contribuição

Pegadinha de prova

O acesso ao SUS não depende de pagamento de contribuição previdenciária. A universalidade afasta a ideia de que somente trabalhadores formalmente inscritos teriam direito ao atendimento.

3. Artigos 196 a 200 da Constituição

O art. 196 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Esse dever deve ser garantido por políticas sociais e econômicas que reduzam o risco de doença e de outros agravos e assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

Observe a amplitude da regra:

- não se limita ao tratamento após o adoecimento;
- exige redução de riscos;
- inclui promoção, proteção e recuperação;
- determina acesso universal e igualitário.

O art. 197 afirma que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública. O Poder Público deve regulamentar, fiscalizar e controlar essas ações, ainda que sua execução possa ocorrer diretamente ou por terceiros.

O art. 198 organiza as ações e os serviços públicos em uma rede regionalizada e hierarquizada e apresenta diretrizes essenciais:

1. descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
2. atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
3. participação da comunidade.

O art. 199 trata da assistência à saúde pela iniciativa privada. A participação privada é livre e pode ocorrer de forma complementar ao SUS, segundo suas diretrizes, com preferência para entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

O art. 200 lista atribuições do SUS, como controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde; executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica e de saúde do trabalhador; ordenar a formação de recursos humanos; participar da política e da execução de ações de saneamento básico; fiscalizar alimentos; e colaborar na proteção do meio ambiente.

4. Aplicação em prova

Uma questão pode afirmar que a Constituição prioriza exclusivamente ações curativas. A afirmação está errada: há prioridade para prevenção, mas sem prejuízo da assistência. Outra formulação frequente diz que a iniciativa privada substitui o SUS. Também está errada: sua atuação pode ser complementar.

5. Erros comuns

- confundir saúde com previdência social;
- exigir contribuição para acesso ao SUS;
- esquecer que prevenção tem prioridade, mas não exclusividade;
- tratar participação privada como substituição da rede pública.

6. Questões comentadas

1. Segundo a Constituição, o acesso às ações e aos serviços de saúde deve ser:

- A) seletivo e contributivo
- B) universal e igualitário
- C) restrito a situações de emergência
- D) condicionado ao vínculo empregatício

Resposta: B. A Constituição garante acesso universal e igualitário.

2. A participação da iniciativa privada no SUS é:

- A) proibida em qualquer hipótese
- B) substitutiva e exclusiva
- C) complementar, conforme as diretrizes do sistema
- D) limitada a ações de vigilância

Resposta: C. O art. 199 admite participação complementar.

7. Resumo do capítulo

A Constituição reconhece saúde como direito de todos e dever estatal. O SUS deve atuar em promoção, proteção e recuperação, com prevenção valorizada, organização regionalizada e hierarquizada, descentralização e participação social.

Capítulo 2 - Lei nº 8.080/1990: organização e funcionamento do SUS

1. Introdução

A Lei nº 8.080/1990 é conhecida como Lei Orgânica da Saúde. Ela desenvolve o modelo constitucional e explica como ações e serviços devem ser organizados.

2. Conceito e campo de atuação

A lei regula, em todo o território nacional, ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente, de forma permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.

O SUS é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. A iniciativa privada pode participar em caráter complementar.

3. Determinantes e condicionantes da saúde

Saúde não depende somente de atendimento médico. Alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e acesso a bens e serviços essenciais influenciam as condições de vida e adoecimento.

Exemplo: dois bairros podem apresentar taxas diferentes de doenças transmitidas por água contaminada. A diferença pode estar ligada à cobertura de saneamento, e não apenas à oferta de consultas.

Aplicação em prova

Quando a questão relaciona saúde às condições sociais, econômicas e ambientais, está trabalhando com determinantes sociais da saúde.

4. Objetivos e atribuições

Entre os objetivos do SUS estão identificar e divulgar fatores condicionantes e determinantes da saúde; formular política de saúde; e prestar assistência por ações de promoção, proteção e recuperação, integrando ações assistenciais e preventivas.

O campo de atuação inclui:

- vigilância sanitária;
- vigilância epidemiológica;
- saúde do trabalhador;

- assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;
- participação em saneamento básico;
- ordenação da formação de recursos humanos;
- vigilância nutricional e orientação alimentar;
- proteção do meio ambiente;
- fiscalização de alimentos, água e bebidas para consumo humano.

5. Princípios e diretrizes

Princípio ou diretriz	Sentido prático
Universalidade	todas as pessoas podem acessar ações e serviços
Integralidade	cuidado articulado, preventivo e assistencial, individual e coletivo
Igualdade da assistência	atendimento sem preconceitos ou privilégios
Autonomia	respeito à integridade física e moral das pessoas
Direito à informação	usuário deve receber informações sobre sua saúde
Descentralização	responsabilidades distribuídas entre entes federativos
Regionalização e hierarquização	serviços organizados por territórios e complexidade
Participação da comunidade	população participa da formulação e do acompanhamento
Resolutividade	serviço deve buscar responder ao problema apresentado

Universalidade, integralidade e equidade

É comum usar a tríade universalidade, integralidade e equidade para compreender o SUS. A universalidade afirma que todos têm direito. A integralidade exige olhar amplo e continuidade do cuidado. A equidade orienta respostas proporcionais às diferentes necessidades para reduzir desigualdades evitáveis.

Exemplo de equidade: disponibilizar recursos de acessibilidade a quem precisa não cria privilégio; corrige uma barreira que impediria acesso efetivo.

6. Direção e competências

A direção do SUS é única em cada esfera:

- União: Ministério da Saúde;
- estados e Distrito Federal: respectivas secretarias de saúde ou órgãos equivalentes;
- municípios: respectivas secretarias de saúde ou órgãos equivalentes.

A descentralização não significa ausência de coordenação. Cada esfera possui atribuições próprias e deve atuar de forma articulada.

7. Erros comuns

- confundir universalidade com gratuidade apenas;
- reduzir integralidade a encaminhamento para especialistas;
- imaginar que descentralização elimina a responsabilidade federal;
- esquecer a participação complementar da iniciativa privada.

8. Questões comentadas

1. A identificação dos fatores determinantes da saúde:

- A) é estranha às atribuições do SUS
- B) integra os objetivos do SUS
- C) cabe somente à assistência social
- D) não possui relação com planejamento

Resposta: B. A Lei nº 8.080/1990 inclui identificar e divulgar determinantes e condicionantes.

2. A direção do SUS no âmbito municipal é exercida:

- A) exclusivamente pelo Ministério da Saúde
- B) pela secretaria municipal de saúde ou órgão equivalente
- C) pelo conselho profissional da categoria
- D) por entidade privada contratada

Resposta: B. Há direção única em cada esfera.

9. Resumo do capítulo

A Lei nº 8.080/1990 organiza o SUS, reconhece determinantes sociais da saúde, estabelece objetivos, atribuições, princípios e repartição de responsabilidades.

Capítulo 3 - Lei nº 8.142/1990: participação social e transferências

1. Introdução

Se a Lei nº 8.080/1990 organiza o SUS, a Lei nº 8.142/1990 destaca dois pontos muito cobrados: participação da comunidade e transferências intergovernamentais de recursos.

2. Conferência de Saúde

A Conferência de Saúde reúne-se a cada quatro anos com representação dos vários segmentos sociais. Sua finalidade é avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Pode ser convocada extraordinariamente.

3. Conselho de Saúde

O Conselho de Saúde possui caráter permanente e deliberativo. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Suas decisões são homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera.

Instância	Periodicidade	Natureza principal
Conferência de Saúde	a cada quatro anos, ordinariamente	avalia situação e propõe diretrizes
Conselho de Saúde	permanente	formula estratégias e controla execução

Pegadinha de prova

O Conselho de Saúde não é reunião eventual nem apenas consultiva. A lei o define como permanente e deliberativo.

4. Transferências intergovernamentais

A lei disciplina repasses regulares e automáticos de recursos entre esferas governamentais. Em prova, atenção para a lógica cooperativa do financiamento e para a exigência de instrumentos de gestão e controle.

Requisitos previstos

Para receber recursos, municípios, estados e Distrito Federal devem contar com estruturas e instrumentos como:

- Fundo de Saúde;
- Conselho de Saúde;
- Plano de Saúde;
- relatórios de gestão que permitam controle;
- contrapartida de recursos no respectivo orçamento;
- comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários, conforme previsão legal.

Atenção

Não memorize essa lista como burocracia solta. Fundo organiza recursos; Conselho participa do controle; Plano orienta prioridades; relatório permite acompanhar resultados.

Representação nos Conselhos

A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Isso reforça participação comunitária.

Caso prático

Um município recebe recursos, mas não divulga resultados e trata o Conselho como reunião simbólica. A prática contraria a lógica do controle social: Conselho atua na formulação de estratégias e no controle da execução, inclusive econômico-financeiro.

5. Erros comuns

- dizer que Conselho é temporário;
- afirmar que Conferência ocorre anualmente;
- confundir homologação das decisões com inexistência de caráter deliberativo;
- esquecer paridade dos usuários;
- tratar fundo, plano e relatório como peças desconectadas.

6. O que mais cai

- Conferência quadrienal;
- Conselho permanente e deliberativo;
- formulação e controle;
- paridade;
- requisitos para transferências;
- acompanhamento financeiro.

7. Questões comentadas

1. A Conferência de Saúde reúne-se ordinariamente:

- A) mensalmente
- B) anualmente
- C) a cada quatro anos
- D) apenas por decisão judicial

Resposta: C.

2. O Conselho de Saúde é:

- A) temporário e consultivo
- B) permanente e deliberativo
- C) privado e independente do SUS
- D) composto somente por gestores

Resposta: B.

3. A representação dos usuários nos Conselhos e Conferências é:

- A) inexistente
- B) paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- C) exclusivamente técnica
- D) facultativa em qualquer situação

Resposta: B.

4. Entre instrumentos relacionados à transferência de recursos está:

- A) Plano de Saúde
- B) apresentação de slides
- C) publicidade comercial
- D) filiação previdenciária individual

Resposta: A.

8. Resumo do capítulo

Controle social não é detalhe administrativo: é diretriz constitucional e aparece institucionalizado em conselhos e conferências. A Lei nº 8.142/1990 também conecta transferências a instrumentos de gestão e acompanhamento.

Capítulo 4 - Organização da atenção: redes e níveis de complexidade

1. Introdução

Uma pessoa pode precisar de vacinação, acompanhamento de hipertensão, consulta especializada, exame de imagem e internação. O sistema precisa organizar fluxos para que o cuidado não seja fragmentado.

2. Níveis de atenção

Atenção primária

É a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde. Atua em território definido e acompanha pessoas, famílias e coletividades. Desenvolve promoção, prevenção, proteção,

diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.

Atenção secundária

Reúne serviços especializados e apoio diagnóstico de maior densidade tecnológica, geralmente acessados conforme a organização da rede.

Atenção terciária

Abrange cuidados de alta complexidade, como procedimentos hospitalares especializados e tecnologias intensivas.

Atenção

A atenção primária não é sinônimo de atendimento simples ou pouco importante. Ela coordena o cuidado e ordena a rede.

3. Regionalização e hierarquização

Regionalizar é organizar serviços considerando territórios e necessidades populacionais. Hierarquizar é estruturar pontos de atenção conforme complexidade e fluxos assistenciais. A pessoa deve chegar ao ponto adequado e ter continuidade do cuidado.

4. Referência e continuidade

Encaminhar não significa abandonar. A equipe que acompanha o usuário deve coordenar informações, observar retornos e manter vínculo. Uma rede bem organizada evita repetição desnecessária de exames, perda de informações e peregrinação do usuário.

5. Questões comentadas

1. A principal porta de entrada da rede é:

- A) atenção primária
- B) terapia intensiva
- C) internação cirúrgica
- D) ambulatório de alta complexidade

Resposta: A.

2. Hierarquização significa:

- A) organizar serviços segundo níveis e fluxos de atenção
- B) impedir encaminhamentos
- C) concentrar tudo na União
- D) excluir ações preventivas

Resposta: A.

6. Resumo do capítulo

A rede articula pontos de atenção. A APS é porta de entrada preferencial, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços.

Capítulo 5 - Atenção Primária à Saúde, PNAB e Estratégia Saúde da Família

Percurso de aprendizagem

Este capítulo apresenta os fundamentos. O Capítulo 25 retoma o tema em formato aplicado, com situações de território, adscrição e encaminhamento. Use os dois em sequência: primeiro conceito, depois decisão prática.

1. Introdução

A PNAB considera equivalentes, em suas concepções atuais, os termos Atenção Básica e Atenção Primária à Saúde. A Estratégia Saúde da Família é prioritária para expansão e consolidação da atenção básica.

2. Território e responsabilidade sanitária

A equipe trabalha com população em território definido. Territorialização é o processo de conhecer esse espaço: população, riscos, equipamentos sociais, condições ambientais, vulnerabilidades e recursos comunitários.

Adscrição é a vinculação de pessoas e famílias a uma equipe ou serviço de referência. Isso favorece acompanhamento longitudinal.

Exemplo: ao identificar alta frequência de abandono do tratamento de hipertensão em determinada área, a equipe pode reorganizar busca ativa e ações educativas.

3. Características da APS

- acesso e acolhimento;
- vínculo;
- continuidade do cuidado;
- coordenação da rede;
- responsabilidade sanitária;
- trabalho multiprofissional;
- ações individuais, familiares e coletivas;
- integração entre assistência e vigilância.

4. Estratégia Saúde da Família

A ESF aproxima o cuidado do território. Sua atuação não se limita à consulta dentro da unidade. Inclui acompanhamento, visitas conforme planejamento, educação em saúde, ações coletivas, identificação de riscos e articulação com a rede.

5. Erros comuns

- reduzir APS a triagem;
- confundir territorialização com endereço cadastral apenas;
- imaginar que ESF trata somente doenças crônicas;
- esquecer promoção, reabilitação e cuidados paliativos na definição da atenção básica.

6. Questões comentadas

1. Adscrição de clientela relaciona-se:

- A) à vinculação da população a uma equipe de referência
- B) à cobrança de contribuição previdenciária
- C) à internação obrigatória
- D) à exclusão de demanda espontânea

Resposta: A.

2. A ESF é considerada:

- A) estratégia prioritária de expansão e consolidação da atenção básica
- B) modalidade exclusiva de atenção hospitalar
- C) substituta do controle social
- D) serviço de alta complexidade

Resposta: A.

7. Resumo do capítulo

A APS trabalha em território, com equipe multiprofissional e responsabilidade sanitária. A ESF organiza proximidade, vínculo e continuidade.

Capítulo 6 - Vigilância em saúde

1. Introdução

Vigilância em saúde observa riscos, agravos e condições que afetam a população para orientar intervenções. Não se limita a produzir estatísticas: deve apoiar decisão e ação.

2. Vigilância epidemiológica

É voltada ao conhecimento, detecção ou prevenção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos.

Exemplo: aumento inesperado de casos de doença transmissível exige investigação, análise e medidas de controle.

3. Vigilância sanitária

Atua sobre riscos decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

Exemplos: inspeção sanitária, controle de produtos, fiscalização de serviços de saúde e análise de condições de funcionamento.

4. Vigilância ambiental

Monitora fatores ambientais que interferem na saúde, como água, ar, solo, vetores e situações de risco ambiental.

5. Saúde do trabalhador

Abrange promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde de trabalhadores expostos a riscos e agravos decorrentes das condições de trabalho.

6. Comparativo

Tipo	Pergunta-guia
Epidemiológica	quais doenças e agravos estão ocorrendo e como controlá-los?
Sanitária	produtos, ambientes e serviços oferecem risco à saúde?
Ambiental	quais fatores ambientais ameaçam a população?
Saúde do trabalhador	quais riscos do trabalho afetam a saúde?

7. Questões comentadas

1. A inspeção de um serviço sujeito a controle sanitário é exemplo de:

- A) vigilância sanitária
- B) previdência social

- C) auditoria tributária
- D) vigilância patrimonial

Resposta: A.

2. O monitoramento de fatores ambientais relacionados à saúde pertence à:

- A) vigilância ambiental
- B) assistência jurídica
- C) gestão escolar
- D) atenção exclusivamente hospitalar

Resposta: A.

8. Resumo do capítulo

As vigilâncias possuem focos diferentes, mas precisam atuar de forma integrada.

Capítulo 7 - Epidemiologia e indicadores de saúde

1. Introdução

Epidemiologia estuda a distribuição e os determinantes dos eventos relacionados à saúde em populações e aplica esse conhecimento ao controle de problemas. O foco é coletivo.

2. Processo saúde-doença

O processo saúde-doença resulta da interação entre fatores biológicos, sociais, econômicos, culturais e ambientais. Não é adequado explicar adoecimento populacional por uma única causa isolada.

3. Incidência e prevalência

Medida	Pergunta respondida
Incidência	quantos casos novos surgiram em determinado período?
Prevalência	quantos casos existem em determinado momento ou período?

Exemplo: em um município havia 120 pessoas em acompanhamento por determinada doença em janeiro. Durante o ano, foram diagnosticados 25 novos casos. Os 25 novos casos interessam ao cálculo de incidência; o total de casos existentes interessa à prevalência.

Pegadinha

Incidência se liga à ocorrência de casos novos. Prevalência retrata o conjunto de casos existentes.

4. Indicadores

Indicadores resumem informações para apoiar planejamento, avaliação e tomada de decisão. Podem se relacionar a morbidade, mortalidade, natalidade, cobertura de serviços e outros aspectos.

5. Transição demográfica e epidemiológica

Transição demográfica envolve mudanças na estrutura etária da população, relacionadas a natalidade, mortalidade e envelhecimento. Transição epidemiológica trata de mudanças no perfil de adoecimento e morte, com coexistência de doenças transmissíveis, condições crônicas e causas externas.

6. Sistemas de informação

Sistemas de informação em saúde organizam dados úteis à vigilância, ao planejamento e à avaliação. Em prova, compreenda sua função: transformar registros em informação para decisão. Qualidade do dado depende de preenchimento correto, oportunidade e consistência.

7. Questões comentadas

1. A medida relacionada a casos novos é:

- A) prevalência
- B) incidência
- C) territorialização
- D) adscrição

Resposta: B.

2. Indicadores de saúde servem para:

- A) apoiar análise, planejamento e avaliação
- B) substituir completamente a análise profissional
- C) dispensar registros
- D) restringir ações preventivas

Resposta: A.

8. Resumo do capítulo

Epidemiologia analisa eventos em populações. Incidência mede casos novos; prevalência observa casos existentes. Indicadores apoiam gestão.

Capítulo 8 - Promoção da saúde e níveis de prevenção

Percurso de aprendizagem

Aqui você diferencia promoção e prevenção. O Capítulo 15 amplia a Política Nacional de Promoção da Saúde e a intersetorialidade.

1. Introdução

Promoção e prevenção se relacionam, mas não são idênticas. A prova costuma explorar essa diferença.

2. Promoção da saúde

Promoção busca ampliar condições para uma vida saudável. Envolve autonomia, participação social, ambientes favoráveis e políticas públicas.

Exemplos: incentivo à atividade física, melhoria do saneamento, ações de alimentação adequada e educação em saúde.

3. Prevenção

Nível	Objetivo	Exemplo
Primária	impedir aparecimento da doença ou reduzir risco	vacinação, ações contra tabagismo
Secundária	detectar precocemente e intervir oportunamente	rastreamento conforme protocolos
Terciária	reduzir danos, incapacidades e complicações	reabilitação após agravo

Algumas referências também discutem prevenção quaternária: evitar intervenções desnecessárias e iatrogenias.

4. Educação em saúde

Educação em saúde não é palestra unilateral. Deve considerar linguagem acessível, contexto de vida, diálogo e construção de autonomia.

5. Questões comentadas

1. Vacinação é exemplo clássico de prevenção:

- A) primária
- B) secundária

- C) terciária
- D) exclusivamente hospitalar

Resposta: A.

2. Promoção da saúde:

- A) limita-se ao tratamento medicamentoso
- B) envolve condições de vida e autonomia
- C) dispensa participação comunitária
- D) ocorre somente após diagnóstico

Resposta: B.

6. Resumo do capítulo

Promoção amplia condições de saúde. Prevenção atua para evitar adoecimento, detectar precocemente ou reduzir danos.

Capítulo 9 - Humanização e acolhimento

Percurso de aprendizagem

Aqui estão os conceitos básicos. O Capítulo 16 desenvolve a Política Nacional de Humanização em atenção e gestão.

1. Introdução

Humanização não é cortesia adicional: integra a qualidade do cuidado. Acolhimento não é uma sala específica nem simples recepção administrativa.

2. Acolhimento

Acolher é receber, escutar, reconhecer necessidades, avaliar riscos e responsabilizar-se pela resposta possível, articulando fluxos quando necessário.

Exemplo: orientar uma pessoa a procurar outro serviço sem avaliar necessidade e sem construir encaminhamento adequado não representa acolhimento.

3. Práticas humanizadas

- escuta qualificada;
- respeito à dignidade, cultura e autonomia;
- linguagem compreensível;
- preservação de privacidade;

- vínculo e responsabilização;
- trabalho em equipe;
- atenção às vulnerabilidades.

4. Erros comuns

- confundir acolhimento com atendimento por ordem de chegada em qualquer situação;
- tratar humanização como gentileza sem organização do cuidado;
- ignorar sigilo e privacidade.

5. Questões comentadas

1. Acolhimento envolve:

- A) apenas entrega de senha
- B) escuta e responsabilização pela resposta
- C) atendimento exclusivamente médico
- D) eliminação de critérios de risco

Resposta: B.

6. Resumo do capítulo

Humanizar significa organizar cuidado respeitoso, acessível e responsável.

Capítulo 10 - Determinantes sociais, políticas públicas e planejamento

Percurso de aprendizagem

Este capítulo introduz a lógica. O Capítulo 19 aprofunda instrumentos de gestão, financiamento, monitoramento e avaliação.

1. Determinantes sociais

As condições em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem influenciam sua saúde. Renda, escolaridade, alimentação, transporte, moradia, saneamento, discriminação e acesso a serviços ajudam a explicar desigualdades.

2. Planejamento em saúde

Planejar é analisar a situação, definir prioridades, estabelecer objetivos, selecionar ações, acompanhar indicadores e avaliar resultados.

Etapa	Pergunta
Diagnóstico	qual é a situação?
Priorização	o que exige resposta primeiro?
Objetivos	onde se pretende chegar?
Ações	o que será feito, por quem e quando?
Monitoramento	a execução está ocorrendo?
Avaliação	houve resultado?

Exemplo: se a cobertura vacinal caiu, não basta realizar campanha genérica. É preciso identificar grupos, territórios, barreiras de acesso e estratégias de busca ativa.

3. Gestão e financiamento

O SUS possui gestão compartilhada entre os entes federativos. O financiamento também envolve responsabilidades das diferentes esferas. Em prova, associe financiamento, planejamento e controle social: recursos públicos precisam de programação, acompanhamento e transparência.

4. Questões comentadas

1. A primeira etapa lógica do planejamento é:

- A) ignorar dados disponíveis
- B) analisar a situação
- C) escolher ações sem prioridade
- D) excluir indicadores

Resposta: B.

5. Resumo do capítulo

Políticas e planos eficazes partem da realidade territorial, definem prioridades e avaliam resultados.

Capítulo 11 - Sistemas de informação em saúde

1. Por que estudar sistemas de informação

Uma política pública precisa conhecer a realidade para decidir onde agir. Sistemas de informação organizam registros sobre nascimentos, óbitos, doenças, agravos e atividades assistenciais. O dado isolado somente se torna útil quando possui qualidade, oportunidade e contexto.

Atenção

Sistema de informação não é mero arquivo eletrônico. Ele apoia vigilância, planejamento, monitoramento e avaliação.

2. Qualidade da informação

Um campo incompleto ou preenchido incorretamente pode distorcer indicadores e atrasar resposta sanitária. A qualidade depende de:

- completude;
- consistência;
- oportunidade;
- identificação correta;
- registro padronizado;
- análise responsável.

Exemplo: se casos de determinada doença deixam de ser notificados, o município pode subestimar transmissão e planejar resposta insuficiente.

3. Sistemas recorrentes

Sistema	Finalidade geral
SINAN / e-SUS Sinan	registrar notificações de doenças e agravos
SIM	organizar informações sobre mortalidade
SINASC	organizar informações sobre nascidos vivos
SISAB	integrar informações da Atenção Primária no contexto da estratégia e-SUS APS

Não é necessário decorar toda tela de cada sistema. Para prova, associe sigla, finalidade e importância para decisão.

4. e-SUS Sinan

O Ministério da Saúde disponibiliza a plataforma e-SUS Sinan para modernizar o registro das notificações de doenças e agravos da lista nacional. A informação registrada auxilia planejamento, definição de prioridades e avaliação do impacto das ações.

5. Aplicação em prova

Uma questão pode afirmar que o SIM acompanha nascidos vivos ou que o SINASC se destina prioritariamente a notificações de agravos. Troque mentalmente cada sigla pela finalidade:

- mortalidade: SIM;
- nascidos vivos: SINASC;
- agravos notificáveis: SINAN/e-SUS Sinan;
- dados da APS: SISAB.

6. Questões comentadas

1. O sistema associado a informações sobre mortalidade é:

- A) SIM
- B) SINASC
- C) SISAB
- D) e-SUS Sinan

Resposta: A.

2. O preenchimento incompleto de registros:

- A) não interfere em decisões
- B) pode prejudicar indicadores e planejamento
- C) melhora oportunidade do dado
- D) dispensa análise territorial

Resposta: B.

7. Resumo do capítulo

Dados de qualidade permitem enxergar necessidades, monitorar riscos e avaliar respostas.

Capítulo 12 - Notificação compulsória e resposta epidemiológica

1. Conceito

Notificação compulsória é comunicação obrigatória à autoridade de saúde sobre ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública nos termos da regulamentação vigente.

O profissional não deve aguardar certeza absoluta quando a norma determina notificação da **suspeita**. A investigação epidemiológica complementará a análise.

2. Fluxo lógico

1. identificar situação notificável;
2. registrar conforme instrumento aplicável;
3. comunicar no prazo previsto;
4. apoiar investigação;
5. orientar medidas de prevenção e controle;
6. acompanhar desfecho conforme responsabilidade do serviço.

3. Imediata ou semanal

A regulamentação define periodicidade. Algumas ocorrências demandam comunicação imediata devido ao risco de disseminação, gravidade ou necessidade de intervenção rápida; outras seguem fluxo semanal.

Pegadinha

Notificar não equivale a divulgar publicamente dados pessoais. Vigilância e sigilo precisam coexistir.

4. Busca ativa

Busca ativa procura casos, contatos ou situações não detectadas espontaneamente. Pode ser importante em surtos, queda de cobertura e acompanhamento territorial.

5. Questões comentadas

1. Quando a norma exige notificação da suspeita, o profissional deve:

- A) aguardar confirmação laboratorial sempre
- B) notificar conforme fluxo aplicável

- C) divulgar dados em rede social
- D) ignorar caso leve

Resposta: B.

2. Busca ativa é:

- A) espera passiva por demanda
- B) procura planejada de situações relevantes
- C) restrição de acesso
- D) substituição da investigação

Resposta: B.

6. Resumo do capítulo

Notificação oportuna possibilita resposta sanitária. Suspeita e confirmação seguem a regulamentação específica.

Capítulo 13 - Imunização e Programa Nacional de Imunizações

1. Introdução

Vacinação é estratégia de prevenção primária e proteção coletiva. O calendário vigente deve sempre ser consultado em fonte oficial, pois esquemas e orientações podem ser atualizados.

2. Calendário nacional

O Calendário Nacional de Vacinação do SUS abrange diferentes fases e grupos: crianças, adolescentes, adultos, pessoas idosas, gestantes e grupos com condições especiais. O Ministério da Saúde publica calendário técnico e orientações atualizadas.

Regra de prova

Quando a questão pede esquema vigente, confira a norma atual. Para compreender o tema, memorize princípios: oportunidade da dose, registro, conservação e segurança.

3. Rede de frio

Imunobiológicos precisam ser conservados nas condições recomendadas. Alteração de temperatura, armazenamento inadequado ou falha de monitoramento podem comprometer qualidade.

Cuidados essenciais

- conferir produto e validade;
- manter conservação indicada;
- registrar administração;
- observar lote e dados necessários;
- orientar retorno;
- acompanhar eventos adversos conforme protocolo;
- realizar busca de faltosos quando planejada.

4. Cobertura vacinal

Cobertura expressa alcance da vacinação em população-alvo. Queda de cobertura pode favorecer retorno ou aumento de doenças preveníveis e exige análise territorial.

5. CRIE

Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais atendem situações clínicas específicas conforme orientações oficiais, oferecendo imunobiológicos indicados para grupos com necessidades especiais.

6. Questões comentadas

1. Vacinação é exemplo de prevenção:

- A) primária
- B) terciária
- C) exclusivamente reabilitadora
- D) administrativa

Resposta: A.

2. O calendário vacinal:

- A) nunca muda
- B) deve ser consultado em fonte oficial vigente
- C) dispensa registro
- D) não inclui grupos especiais

Resposta: B.

7. Resumo do capítulo

Imunização exige calendário vigente, rede de frio, registro e vigilância.

Capítulo 14 - Pacto pela Saúde e articulação interfederativa

1. Contexto

O Pacto pela Saúde foi divulgado pela Portaria GM/MS nº 399/2006 como parte da consolidação do SUS. Ele buscou qualificar pactuações e enfrentar fragmentação, respeitando descentralização e diversidade regional.

2. Três componentes

Componente	Foco
Pacto pela Vida	compromissos sanitários e prioridades com foco em resultados
Pacto em Defesa do SUS	defesa dos princípios e fortalecimento do sistema público
Pacto de Gestão	responsabilidades e qualificação da gestão

3. Leitura atual

Normas posteriores modificaram exigências administrativas específicas, como adesão ou assinatura de termo para certos repasses. Ainda assim, os três componentes seguem relevantes para compreender a história da gestão interfederativa e sua lógica de pactuação.

Pegadinha

Estudar Pacto pela Saúde não significa ignorar alterações posteriores. Diferencie conteúdo histórico-estruturante de exigência administrativa vigente.

4. Questões comentadas

1. O Pacto pela Saúde de 2006 possui:

- A) dois componentes
- B) três componentes
- C) somente ações privadas
- D) apenas metas hospitalares

Resposta: B.

5. Resumo do capítulo

O Pacto pela Saúde ajudou a organizar compromissos sanitários, defesa do SUS e responsabilidades de gestão.

Capítulo 15 - Política Nacional de Promoção da Saúde

1. Introdução

A promoção da saúde atua sobre determinantes e condicionantes. Não basta recomendar escolhas individuais quando ambiente, renda, trabalho e acesso limitam possibilidades.

2. Intersetorialidade

Problemas complexos exigem articulação entre saúde, educação, assistência, mobilidade, saneamento, cultura, esporte e outros setores.

Exemplo: reduzir sedentarismo não depende apenas de aconselhamento clínico; espaços públicos seguros e acessíveis também importam.

3. Participação e autonomia

A PNPS valoriza participação social, autonomia e atuação territorial. A pessoa não é mera receptora passiva de recomendações.

4. Questões comentadas

1. Promoção da saúde:

- A) restringe-se à consulta individual
- B) pode exigir ação intersetorial
- C) ignora território
- D) substitui prevenção

Resposta: B.

5. Resumo do capítulo

Promoção busca qualidade de vida e redução de vulnerabilidades por políticas e ações articuladas.

Capítulo 16 - Política Nacional de Humanização

1. Humanização na atenção e gestão

A PNH propõe mudanças nas práticas de atenção e gestão. Sua lógica inclui protagonismo de usuários e trabalhadores, corresponsabilização e construção coletiva.

2. Acolhimento com avaliação de risco

Acolher não é apenas distribuir senhas. Avaliar risco ajuda a priorizar necessidades clínicas, organizar fluxo e oferecer resposta adequada.

3. Direitos e participação

A humanização valoriza informação ao usuário, participação na gestão, respeito à presença de acompanhante nos contextos aplicáveis e reconhecimento dos profissionais envolvidos no cuidado.

4. Questão comentada

1. Acolhimento com avaliação de risco:

- A) organiza assistência considerando necessidades
- B) elimina escuta
- C) restringe atenção a ordem de chegada
- D) dispensa responsabilização

Resposta: A.

5. Resumo do capítulo

Humanização combina escuta, organização, participação e corresponsabilidade.

Capítulo 17 - Decreto nº 7.508/2011: regionalização, acesso e articulação

1. Introdução ao tema

O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080/1990 em pontos importantes: organização do SUS, planejamento, assistência à saúde e articulação interfederativa. Ele ajuda a transformar princípios gerais em regras de funcionamento da rede.

2. Região de Saúde

Região de Saúde é espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes. Sua delimitação considera identidades culturais, econômicas e sociais e redes compartilhadas de comunicação e transporte. A finalidade é integrar organização, planejamento e execução de ações e serviços.

Para ser instituída, deve conter, no mínimo:

1. atenção primária;
2. urgência e emergência;
3. atenção psicossocial;
4. atenção ambulatorial especializada e hospitalar;
5. vigilância em saúde.

Exemplo prático: um município pequeno pode não possuir todos os serviços especializados. A organização regional permite definir fluxos para que seus moradores acessem outros pontos da rede sem romper continuidade.

3. Rede de Atenção à Saúde

Rede de Atenção à Saúde é o conjunto de ações e serviços articulados em níveis de complexidade crescente para garantir integralidade. Rede não é lista de estabelecimentos: pressupõe comunicação, fluxos e continuidade.

4. Portas de entrada

O decreto enumera portas de entrada:

- atenção primária;
- urgência e emergência;
- atenção psicossocial;
- serviços especiais de acesso aberto.

Serviços hospitalares e ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade, são referenciados pelas portas de entrada.

Pegadinha de prova

Atenção primária é ordenadora do acesso, mas não é a única porta de entrada prevista no Decreto nº 7.508/2011.

5. Mapa da Saúde

Mapa da Saúde descreve geograficamente distribuição de recursos humanos, ações e serviços públicos e privados, capacidade instalada, investimentos e desempenho aferido por indicadores. Ele apoia planejamento integrado.

6. RENAME e assistência farmacêutica

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais reúne seleção e padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou agravos no SUS. Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas orientam critérios diagnósticos, tratamento, posologias, controle clínico e acompanhamento de resultados.

7. Comissões Intergestores

São instâncias de pactuação consensual entre entes federativos para regras da gestão compartilhada. A lógica é cooperativa: descentralizar não significa desarticular.

8. Erros comuns

- tratar região de saúde como limite administrativo de um único município;
- afirmar que APS é a única porta de entrada;
- confundir rede com conjunto desconectado de unidades;
- esquecer vigilância em saúde entre componentes mínimos regionais;
- imaginar que RENAME é lista elaborada livremente por cada unidade.

9. O que mais cai

- conceito de Região de Saúde;
- serviços mínimos;
- portas de entrada;
- papel ordenador da APS;
- continuidade do cuidado;
- diferença entre rede, mapa e região;
- RENAME e protocolos clínicos.

10. Questões comentadas

1. Entre os componentes mínimos de uma Região de Saúde está:

- A) apenas atenção hospitalar
- B) vigilância em saúde

- C) somente previdência social
- D) exclusivamente serviço privado

Resposta: B. O decreto lista vigilância ao lado de APS, urgência, atenção psicossocial e atenção especializada/hospitalar.

2. A atenção psicossocial:

- A) não constitui porta de entrada
- B) constitui uma das portas de entrada previstas
- C) substitui toda APS
- D) pertence somente à assistência social

Resposta: B.

11. Resumo do capítulo

O Decreto nº 7.508/2011 detalha organização regional, portas de entrada, rede, planejamento e articulação. Memorize conceitos sem perder a lógica: garantir acesso ordenado e cuidado contínuo.

Capítulo 18 - Saúde do trabalhador

1. Introdução

Saúde do trabalhador integra o campo de atuação do SUS. Ela não se limita a acidentes visíveis: investiga relações entre processos de trabalho, ambientes, riscos e adoecimento.

2. Conceito legal

A Lei nº 8.080/1990 trata saúde do trabalhador como conjunto de atividades destinado, por ações de vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção e proteção, bem como à recuperação e reabilitação de trabalhadores submetidos a riscos e agravos das condições de trabalho.

3. Vigilância em Saúde do Trabalhador

A VISAT desenvolve ações contínuas e sistemáticas para detectar, conhecer, pesquisar e analisar fatores determinantes e condicionantes dos agravos relacionados ao trabalho. A finalidade é subsidiar intervenções para eliminar ou controlar riscos.

4. Exemplos de situações

- acidente com material biológico;
- exposição a ruído;
- dermatoses relacionadas ao trabalho;

- transtornos mentais relacionados ao trabalho;
- lesões por esforços repetitivos e doenças osteomusculares;
- exposição a substâncias químicas.

5. Erros comuns

- restringir saúde do trabalhador ao emprego formal;
- confundir prevenção com concessão de benefício previdenciário;
- ignorar ambiente e organização do trabalho;
- tratar acidente como evento sem necessidade de vigilância.

6. O que mais cai

- conceito da Lei nº 8.080/1990;
- relação entre vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador;
- promoção, proteção, recuperação e reabilitação;
- investigação a partir da suspeita.

7. Questão comentada

1. Saúde do trabalhador:

- A) limita-se à previdência social
- B) integra campo de atuação do SUS
- C) exclui prevenção
- D) trata apenas aposentadoria

Resposta: B.

8. Resumo do capítulo

Saúde do trabalhador observa riscos do processo laboral e organiza ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação.

Capítulo 19 - Planejamento, instrumentos de gestão e financiamento

1. Introdução

O SUS precisa transformar necessidades da população em prioridades, metas, ações e orçamento. Planejamento não é mera formalidade administrativa: orienta escolhas diante de recursos limitados e

permite avaliar se a política produziu resultados.

2. Planejamento ascendente e integrado

O Decreto nº 7.508/2011 estabelece que o processo de planejamento da saúde seja ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde. O planejamento deve compatibilizar necessidades das políticas de saúde com disponibilidade de recursos financeiros.

Exemplo: uma equipe identifica baixa cobertura vacinal em determinado território. O diagnóstico local alimenta planejamento municipal, que organiza busca ativa, horários, equipes e recursos. Informações agregadas também orientam decisões regionais, estaduais e nacionais.

Pegadinha

Planejamento ascendente não elimina coordenação nacional. Ele valoriza informações e necessidades locais dentro de processo articulado.

3. Instrumentos básicos

Instrumento	Função geral
Plano de Saúde	organiza diretrizes, objetivos e metas para período de gestão
Programação Anual de Saúde	operacionaliza, em cada ano, intenções do Plano
Relatório Anual de Gestão	apresenta resultados alcançados e subsidia avaliação

Esses instrumentos precisam dialogar. Não faz sentido estabelecer ação anual sem relação com planejamento ou avaliar resultados sem metas previamente definidas.

4. Monitoramento e avaliação

Monitorar é acompanhar execução durante o processo. Avaliar é analisar resultados, efeitos e adequação das escolhas. Indicadores ajudam, mas não substituem leitura qualitativa do território.

Exemplo: contar consultas realizadas informa produção. Para avaliar qualidade, é preciso observar também acesso, continuidade, desfechos e necessidades não atendidas.

5. Financiamento

O financiamento do SUS é responsabilidade compartilhada entre União, estados, Distrito Federal e municípios. A Constituição e normas complementares estruturam aplicação de recursos e responsabilidades.

Para prova, retenha a lógica:

- financiamento é tripartite;
- aplicação de recursos exige planejamento;
- controle social acompanha execução;
- transparência e prestação de contas são essenciais;
- descentralização não significa transferência integral de responsabilidade a municípios.

6. Fundos de Saúde

Os Fundos de Saúde organizam recursos destinados às ações e aos serviços. A Lei nº 8.142/1990 relaciona transferências e requisitos de gestão, como fundo, conselho, plano e relatórios.

7. Erros comuns

- confundir plano plurianual de saúde com programação anual;
- tratar relatório como documento sem função avaliativa;
- imaginar que financiamento cabe apenas à União;
- separar orçamento, planejamento e controle social;
- analisar quantidade produzida como único indicador de qualidade.

8. O que mais cai

- planejamento ascendente;
- plano, programação e relatório;
- responsabilidade compartilhada;
- papel do controle social;
- conexão entre indicadores, metas e avaliação.

9. Questões comentadas

1. O planejamento do SUS deve ser:

- A) isolado em cada estabelecimento
- B) ascendente e integrado
- C) exclusivamente federal
- D) desvinculado de recursos

Resposta: B. O decreto prevê integração do nível local ao federal.

2. A Programação Anual de Saúde:

- A) operacionaliza ações anuais relacionadas ao planejamento
- B) substitui definitivamente o Plano de Saúde
- C) dispensa avaliação
- D) elimina indicadores

Resposta: A.

3. O financiamento do SUS:

- A) pertence exclusivamente ao município
- B) envolve responsabilidades compartilhadas
- C) dispensa transparência
- D) não se relaciona a planejamento

Resposta: B.

10. Resumo do capítulo

Planejamento parte das necessidades, define prioridades e acompanha resultados. Instrumentos de gestão, recursos e controle social precisam permanecer conectados.

Capítulo 20 - Integralidade na prática: linhas de cuidado e coordenação

1. Introdução

Integralidade pode parecer abstrata. Na prática, significa não reduzir uma pessoa a procedimento isolado e organizar continuidade entre promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados necessários.

2. Coordenação do cuidado

A Atenção Primária acompanha trajetórias e articula informações. Encaminhar para especialista não rompe responsabilidade. Quando há retorno, equipe precisa incorporar orientações ao plano de cuidado.

Exemplo: pessoa com diabetes acompanhada na APS desenvolve complicação e é encaminhada. A APS mantém vínculo, acompanha tratamento e trabalha prevenção de novos agravos.

3. Linhas de cuidado

Linhas de cuidado ajudam a organizar percurso esperado dentro da rede, articulando pontos de atenção conforme necessidades. Elas não são roteiros rígidos: consideram singularidades e recursos regionais.

4. Continuidade e vínculo

Continuidade reduz fragmentação. O usuário não deve repetir sua história indefinidamente nem peregrinar sem orientação. Registros, comunicação e referência adequada sustentam vínculo.

5. Erros comuns

- tratar integralidade como oferta ilimitada sem organização;
- reduzir coordenação a encaminhamento;
- supor que especialista substitui completamente APS;
- ignorar prevenção após diagnóstico.

6. O que mais cai

- cuidado articulado;
- papel coordenador da APS;
- continuidade;
- rede;
- prevenção e assistência sem oposição.

7. Questão comentada

1. Integralidade significa:

- A) atendimento isolado
- B) articulação de ações conforme necessidades da pessoa e coletividade
- C) exclusão de prevenção
- D) apenas consulta especializada

Resposta: B.

8. Resumo do capítulo

Integralidade organiza cuidado contínuo e articulado. APS, serviços especializados e demais pontos da rede precisam atuar de forma comunicante.

Capítulo 21 - Casos integradores de Saúde Pública

1. Como resolver questões situacionais

Questões de SUS frequentemente descrevem problema do território. Não procure palavra isolada. Pergunte:

1. qual necessidade aparece?
2. é individual, coletiva ou ambas?
3. qual princípio orienta resposta?

4. qual ponto da rede participa?
5. há vigilância, notificação ou planejamento?
6. a ação exige articulação intersetorial?

2. Caso 1 - Queda de cobertura vacinal

Uma equipe identifica redução da cobertura em crianças de determinado território. A resposta não deve se limitar a aguardar comparecimento espontâneo.

Análise

- utilizar registros confiáveis;
- identificar grupos e áreas com atraso;
- avaliar barreiras de acesso;
- organizar busca ativa;
- orientar famílias;
- monitorar resultados;
- manter conservação e registro corretos;
- articular ações conforme necessidade.

Conceitos envolvidos

APS, território, imunização, sistemas de informação, planejamento e prevenção primária.

Questão comentada

1. A resposta mais adequada inclui:

- A) aguardar passivamente
- B) analisar dados e organizar estratégia territorial
- C) dispensar registro
- D) excluir famílias com atraso

Resposta: B.

3. Caso 2 - Aumento de casos de doença transmissível

Unidades registram aumento inesperado de suspeitas em curto período.

Análise

- reconhecer possível mudança epidemiológica;
- notificar conforme norma;
- investigar;
- identificar contatos e fatores;

- adotar medidas de controle;
- comunicar adequadamente sem violar sigilo;
- acompanhar evolução.

Conceitos envolvidos

Vigilância epidemiológica, incidência, notificação e resposta oportuna.

Pegadinha

Quando a norma exige notificação da suspeita, aguardar confirmação pode atrasar controle.

4. Caso 3 - Barreira geográfica

Moradores de área distante faltam a consultas porque transporte é insuficiente.

Análise

O problema não é apenas escolha individual. Transporte é determinante e barreira de acesso. A resposta pode exigir organização territorial, articulação intersetorial e adequação de fluxos.

Conceitos envolvidos

Equidade, determinantes sociais, planejamento e intersetorialidade.

5. Caso 4 - Usuário encaminhado sem continuidade

Uma pessoa com condição crônica recebe encaminhamento, mas não consegue compreender o fluxo e perde seguimento.

Análise

Encaminhamento sem coordenação pode fragmentar cuidado. APS precisa orientar, acompanhar e integrar informações conforme organização da rede.

Conceitos envolvidos

Integralidade, vínculo, coordenação e referência.

6. Caso 5 - Denúncia sanitária

Há suspeita de problema em serviço sujeito à fiscalização sanitária.

Análise

A situação envolve vigilância sanitária, responsável por prevenir ou eliminar riscos ligados a bens, serviços e ambientes de interesse da saúde.

Conceitos envolvidos

Vigilância sanitária e relevância pública das ações de saúde.

7. Caso 6 - Acidente relacionado ao trabalho

Trabalhadores relatam adoecimento repetido após exposição no processo laboral.

Análise

A resposta deve considerar vigilância em saúde do trabalhador, identificação de riscos e medidas de proteção, não somente tratamento individual.

Conceitos envolvidos

VISAT, promoção, proteção, recuperação e reabilitação.

8. Erros comuns

- reduzir problema coletivo a consulta individual;
- ignorar território;
- confundir vigilâncias;
- tratar encaminhamento como fim da responsabilidade;
- esquecer determinantes;
- propor divulgação indevida de dados pessoais.

9. O que mais cai

- aplicação de princípios;
- integração APS-vigilância;
- incidência e notificação;
- equidade;
- intersetorialidade;
- coordenação da rede.

10. Resumo do capítulo

O SUS funciona quando princípios, dados, território e rede orientam respostas concretas.

Capítulo 22 - Bateria comentada de Saúde Pública

1. Uma ação que reduz barreira de acesso para grupo vulnerável expressa:

- A) equidade
- B) exclusão
- C) contribuição previdenciária
- D) centralização absoluta

Resposta: A. Equidade responde a necessidades diferentes para reduzir desigualdades evitáveis.

2. Casos novos de uma doença em período definido correspondem a:

- A) prevalência
- B) incidência
- C) integralidade
- D) adscrição

Resposta: B.

3. Conselho de Saúde possui caráter:

- A) eventual e privado
- B) permanente e deliberativo
- C) quadrienal apenas
- D) exclusivamente técnico

Resposta: B.

4. Conferência de Saúde reúne-se ordinariamente:

- A) semanalmente
- B) mensalmente
- C) a cada quatro anos
- D) a cada dez anos

Resposta: C.

5. Entre portas de entrada previstas no Decreto nº 7.508/2011 está:

- A) atenção psicossocial
- B) somente internação
- C) apenas laboratório privado
- D) faturamento

Resposta: A.

6. SIM organiza dados principalmente sobre:

- A) mortalidade
- B) nascidos vivos
- C) vacinação exclusivamente
- D) slides

Resposta: A.

7. SINASC organiza informações sobre:

- A) nascidos vivos
- B) óbitos
- C) medicamentos apenas
- D) acidentes somente

Resposta: A.

8. Vigilância sanitária atua:

- A) sobre riscos relacionados a produtos, serviços e ambientes de interesse da saúde
- B) somente em aposentadorias
- C) apenas em hospitais públicos
- D) exclusivamente em gráficos

Resposta: A.

9. Vacinação é medida típica de prevenção:

- A) primária
- B) terciária
- C) exclusivamente hospitalar
- D) previdenciária

Resposta: A.

10. Acolhimento:

- A) limita-se a entregar senha
- B) envolve escuta e responsabilização
- C) impede avaliação de risco
- D) elimina fluxo

Resposta: B.

11. Descentralização significa:

- A) desarticulação
- B) distribuição de responsabilidades com coordenação
- C) responsabilidade municipal exclusiva
- D) fim da esfera estadual

Resposta: B.

12. Planejamento ascendente:

- A) valoriza informações locais em processo integrado
- B) exclui participação social
- C) ignora recursos
- D) começa somente no nível federal

Resposta: A.

13. A RENAME relaciona-se:

- A) a medicamentos essenciais
- B) apenas a óbitos
- C) a vigilância patrimonial
- D) a ensino privado

Resposta: A.

14. Promoção da saúde:

- A) considera determinantes e pode exigir intersetorialidade
- B) restringe-se a prescrição
- C) elimina autonomia
- D) acontece apenas após doença

Resposta: A.

15. Notificação compulsória:

- A) pode ser exigida já na suspeita, conforme norma
- B) sempre espera confirmação definitiva
- C) autoriza divulgação pública dos dados
- D) dispensa fluxo institucional

Resposta: A.

Como revisar

Separe erros por eixo:

- Constituição e leis;
- princípios;
- gestão e participação;
- rede e APS;
- vigilâncias;
- epidemiologia;
- políticas e planejamento.

Capítulo 23 - Lei Complementar nº 141/2012 comentada

Conexão com o Capítulo 19

O Capítulo 19 explica a lógica de planejamento e financiamento. Este capítulo concentra a leitura legal da LC nº 141/2012: mínimos, rateio, transparência, fiscalização e controle social.

1. Introdução

A Lei Complementar nº 141/2012 regulamenta pontos do art. 198 da Constituição relacionados ao financiamento da saúde. Ela trata de valores mínimos, critérios de rateio, fiscalização, avaliação e controle das despesas.

2. O que a lei organiza

Eixo	Sentido
Aplicação mínima	define regras para recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde
Rateio	orienta critérios para transferências visando reduzir disparidades
Transparência	exige divulgação e visibilidade
Fiscalização	articula controles e acompanhamento
Participação	reconhece papel dos Conselhos de Saúde

3. Ações e serviços públicos de saúde

Para apuração dos recursos mínimos, despesas precisam se voltar a promoção, proteção e recuperação, atender princípios do SUS e cumprir diretrizes legais, como acesso universal, igualitário e gratuito e conformidade com objetivos e metas dos Planos de Saúde.

Pegadinha

Nem toda despesa relacionada genericamente ao bem-estar pode ser contabilizada automaticamente como ação e serviço público de saúde. A lei define critérios.

4. Transparência

A lei prevê ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas, com ênfase em cumprimento da lei, Relatório de Gestão e avaliação do Conselho de Saúde.

5. Conselhos e prioridades

Conselhos de Saúde deliberam sobre diretrizes para estabelecimento de prioridades. Participação social se conecta a planejamento e controle.

6. Caso prático

Um gestor deseja criar ação anual sem relação com Plano de Saúde e sem divulgação dos resultados. A proposta fere lógica de planejamento, transparência e controle social.

7. Erros comuns

- memorizar percentuais sem compreender finalidade;
- tratar transparência como opção;
- separar plano e orçamento;
- imaginar que conselho não participa da definição de prioridades;
- incluir qualquer despesa no cálculo.

8. O que mais cai

- mínimos e rateio;
- controle;
- transparência;
- planos;
- participação dos Conselhos;
- redução de disparidades regionais.

9. Questões comentadas

1. A LC nº 141/2012 trata:

- A) de financiamento, rateio e fiscalização das despesas em saúde
- B) apenas de previdência
- C) somente de hospitais privados
- D) exclusivamente de vacinação

Resposta: A.

2. A transparência:

- A) deve incluir divulgação de prestações de contas
- B) é dispensável
- C) exclui participação popular
- D) não alcança relatórios

Resposta: A.

3. Os Conselhos de Saúde:

- A) não participam das prioridades
- B) deliberam sobre diretrizes para prioridades

- C) são apenas privados
- D) substituem todos os gestores

Resposta: B.

10. Resumo do capítulo

A LC nº 141/2012 conecta recursos, planejamento, transparência, fiscalização e participação social.

Capítulo 24 - Assistência terapêutica integral e incorporação de tecnologias

1. Introdução

A Lei nº 8.080/1990 inclui assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, no campo de atuação do SUS. Esse tema ajuda a compreender que integralidade não se resume a consulta: envolve medicamentos, produtos e procedimentos organizados segundo critérios.

2. Assistência terapêutica integral

Nos termos legais, abrange:

- dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde;
- prescrição em conformidade com diretrizes terapêuticas definidas em protocolos clínicos ou regras aplicáveis;
- oferta de procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar conforme organização do SUS.

3. Produtos de interesse para a saúde

A lei apresenta exemplos como órteses, próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos. Não se trata de lista comercial livre: a oferta integra critérios e organização pública.

4. Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas

Protocolos orientam diagnóstico, tratamento, medicamentos, posologias, controle clínico e acompanhamento de resultados conforme evidências e normas. Padronização contribui para segurança e equidade.

5. Relação com RENAME

A RENAME reúne medicamentos essenciais no âmbito do SUS. Em prova, associe:

Elemento	Ideia
Assistência terapêutica	oferta organizada de medicamentos, produtos e procedimentos
PCDT	critérios clínicos e terapêuticos
RENAME	relação nacional de medicamentos essenciais
Integralidade	cuidado articulado conforme necessidades

6. Caso prático

Uma questão afirma que integralidade farmacêutica significa acesso irrestrito a qualquer produto por decisão isolada. A afirmação está incorreta. O SUS organiza assistência conforme protocolos, evidências, incorporação e normas.

7. Erros comuns

- reduzir assistência terapêutica a entrega de medicamentos;
- ignorar protocolos;
- confundir essencialidade com escolha individual irrestrita;
- separar cuidado farmacêutico da integralidade.

8. O que mais cai

- art. 6º e arts. 19-M e seguintes da Lei nº 8.080/1990;
- assistência integral;
- medicamentos e produtos;
- PCDT;
- RENAME.

9. Questões comentadas

1. Assistência terapêutica integral:

- A) inclui medicamentos, produtos e procedimentos organizados
- B) limita-se a internações
- C) dispensa protocolos
- D) exclui cuidado domiciliar

Resposta: A.

2. PCDT:

- A) orienta critérios clínicos e terapêuticos
- B) substitui toda legislação

- C) é lista de contribuintes
- D) exclui acompanhamento

Resposta: A.

10. Resumo

Assistência terapêutica integra cuidado e segue critérios públicos, clínicos e normativos.

Capítulo 25 - PNAB aplicada: território, adscrição e encaminhamento responsável

Conexão com o Capítulo 5

O Capítulo 5 oferece a base conceitual da APS. Este módulo é a oficina aplicada: releia os casos pensando em território, vínculo e continuidade.

1. Introdução

A PNAB aprovada pela Portaria nº 2.436/2017 organiza a Atenção Básica na Rede de Atenção à Saúde. Ela oferece conceitos muito cobrados em questões situacionais.

2. Território

Território não é somente endereço. Reúne dimensões ambientais, históricas, demográficas, econômicas, sanitárias, sociais e culturais. Conhecê-lo ajuda a programar ações.

3. População adscrita

É população presente no território da unidade, vinculada para fortalecer referência, vínculo, responsabilização, continuidade e longitudinalidade.

4. Porta de entrada preferencial

A Atenção Básica atua como contato preferencial e ordenadora da rede. Isso não significa exclusividade: o Decreto nº 7.508/2011 prevê outras portas.

5. Encaminhamento responsável

Encaminhar não encerra cuidado. A equipe mantém vinculação e coordenação.

Exemplo: pessoa encaminhada para especialista retorna com orientação. APS acompanha adesão e integra o plano.

6. Caso territorial

Uma equipe identifica maior incidência de determinada condição em área sem saneamento adequado. A resposta inclui analisar determinantes, articular setores e planejar ações, não apenas ampliar consultas.

7. Erros comuns

- reduzir território a mapa;
- confundir adscrição com exclusão de atendimento;
- tratar APS como triagem;
- perder vínculo após encaminhamento;
- ignorar determinantes.

8. O que mais cai

- territorialização;
- adscrição;
- vínculo;
- longitudinalidade;
- coordenação;
- encaminhamento responsável;
- ESF como estratégia prioritária.

9. Questões comentadas

1. Territorialização:

- A) considera características do espaço e da população
- B) limita-se ao CEP
- C) exclui cultura
- D) impede planejamento

Resposta: A.

2. Encaminhamento responsável:

- A) rompe vínculo
- B) mantém coordenação do cuidado
- C) elimina APS
- D) transfere toda responsabilidade

Resposta: B.

10. Resumo

A PNAB conecta território, vínculo, acesso e rede. APS ordena cuidado sem se isolar.

Capítulo 26 - Revisão estratégica

Quadro de alta incidência em prova

Tema	Memorize
Constituição	saúde é direito de todos e dever do Estado
Art. 198	descentralização, integralidade e participação comunitária
Lei nº 8.080/1990	organização, princípios, objetivos e campos de atuação
Lei nº 8.142/1990	conselho permanente e deliberativo; conferência a cada quatro anos
APS	porta de entrada preferencial, coordenadora do cuidado
ESF	estratégia prioritária da atenção básica
Incidência	casos novos
Prevalência	casos existentes
Vigilâncias	epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador
Prevenção	primária, secundária e terciária
Sistemas	SIM: óbitos; SINASC: nascidos vivos; SINAN: agravos; SISAB: APS
Notificação	observar suspeita/confirmação e prazo definidos na norma
Imunização	calendário vigente, conservação, registro e cobertura
Pacto pela Saúde	Vida, Defesa do SUS e Gestão
Decreto nº 7.508/2011	região, rede, portas de entrada, mapa, RENAME e pactuação
Saúde do trabalhador	promoção, proteção, recuperação e vigilância dos riscos laborais

Simulado comentado

1. O princípio que garante acesso a todas as pessoas é:

- A) regionalização
- B) universalidade
- C) hierarquização
- D) adscrição

Resposta: B.

2. A avaliação da situação de saúde e proposição de diretrizes ocorre, ordinariamente a cada quatro anos, na:

- A) conferência de saúde
- B) unidade hospitalar
- C) vigilância sanitária
- D) secretaria de fazenda

Resposta: A.

3. A detecção precoce de doença em população-alvo relaciona-se mais diretamente à prevenção:

- A) primária
- B) secundária
- C) terciária
- D) ambiental

Resposta: B.

4. Territorialização significa:

- A) conhecer população, riscos e recursos de determinada área
- B) limitar atendimento à internação
- C) excluir demanda espontânea
- D) substituir indicadores

Resposta: A.

5. Casos novos diagnosticados em um período interessam ao cálculo de:

- A) prevalência
- B) incidência
- C) integralidade
- D) equidade

Resposta: B.

6. O sistema associado a nascidos vivos é:

- A) SINASC
- B) SIM
- C) SISAB
- D) Cco

Resposta: A.

7. A queda de cobertura vacinal:

- A) não exige análise
- B) pode aumentar risco de doenças preveníveis
- C) dispensa busca ativa
- D) elimina necessidade de registro

Resposta: B.

8. Segundo o Decreto nº 7.508/2011, é porta de entrada:

- A) atenção psicossocial
- B) apenas centro cirúrgico
- C) somente serviço privado
- D) laboratório isolado

Resposta: A.

9. A VISAT:

- A) ignora processos de trabalho
- B) busca detectar e analisar fatores relacionados a agravos laborais
- C) restringe-se ao pagamento de benefícios
- D) exclui prevenção

Resposta: B.

Bloco adicional de questões comentadas

10. Atendimento integral no SUS significa:

- A) oferecer somente tratamento hospitalar
- B) articular ações preventivas e assistenciais conforme necessidades
- C) excluir promoção da saúde
- D) limitar cuidado a um procedimento

Resposta: B. Integralidade combate fragmentação e considera diferentes necessidades.

11. A participação da comunidade aparece institucionalizada especialmente em:

- A) conselhos e conferências de saúde
- B) empresas privadas apenas
- C) receitas médicas
- D) arquivos pessoais

Resposta: A.

12. Vigilância sanitária relaciona-se principalmente:

- A) ao controle de riscos ligados a produtos, serviços e ambientes de interesse da saúde
- B) somente ao cálculo de mortalidade
- C) ao pagamento de aposentadorias
- D) apenas à consulta individual

Resposta: A.

13. Incidência elevada indica:

- A) aumento de casos novos em período considerado
- B) apenas número total histórico
- C) exclusão de casos novos
- D) ausência de transmissão

Resposta: A.

14. Uma ação de reabilitação após agravo relaciona-se à prevenção:

- A) primária
- B) secundária
- C) terciária
- D) sanitária exclusivamente

Resposta: C.

15. O Conselho de Saúde é:

- A) permanente e deliberativo
- B) reunião quadrienal apenas
- C) privado
- D) exclusivamente consultivo

Resposta: A.

16. A Conferência de Saúde:

- A) ocorre ordinariamente a cada quatro anos
- B) substitui o Conselho permanentemente
- C) reúne apenas prestadores
- D) trata apenas de previdência

Resposta: A.

17. O SINASC está associado:

- A) a nascidos vivos
- B) exclusivamente a óbitos
- C) a transições de slides
- D) a prontuário individual apenas

Resposta: A.

18. Equidade orienta:

- A) respostas proporcionais às necessidades para reduzir desigualdades evitáveis
- B) exclusão de vulneráveis
- C) atendimento contributivo
- D) oferta idêntica sem considerar barreiras

Resposta: A.

19. A descentralização:

- A) elimina articulação entre entes
- B) distribui responsabilidades mantendo coordenação

- C) extingue esfera municipal
- D) impede planejamento regional

Resposta: B.

20. Acolhimento:

- A) é somente recepção burocrática
- B) envolve escuta, avaliação de necessidades e responsabilização
- C) exclui avaliação de risco
- D) impede encaminhamento

Resposta: B.

Como revisar seus erros

Classifique cada erro:

- **conceito:** não compreendeu a definição;
- **troca:** confundiu conceitos próximos;
- **leitura:** ignorou palavra como “apenas”, “exclusivamente” ou “sempre”;
- **memorização:** esqueceu sigla, periodicidade ou componente;
- **aplicação:** sabia definição, mas não reconheceu no exemplo.

Essa classificação orienta revisão mais eficiente do que reler tudo indiscriminadamente.

Roteiro de revisão integrada

Eixo 1 - Base jurídica

Revise Constituição, Lei nº 8.080/1990, Lei nº 8.142/1990, Decreto nº 7.508/2011 e Lei Complementar nº 141/2012. Não tente memorizar normas como blocos isolados. Pergunte qual problema cada uma organiza:

- Constituição: direito e diretrizes;
- Lei nº 8.080/1990: organização, princípios e campo de atuação;
- Lei nº 8.142/1990: participação e transferências;
- Decreto nº 7.508/2011: região, rede, acesso, planejamento e articulação;
- LC nº 141/2012: financiamento, transparência e fiscalização.

Eixo 2 - Território e rede

Conecte APS, ESF, adscrição, territorialização, portas de entrada, região de saúde e integralidade.

Eixo 3 - Vigilância

Diferencie epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador. Em seguida, relacione notificação, sistemas e indicadores.

Eixo 4 - Políticas

Revise promoção, prevenção, humanização, acolhimento e participação social.

Questão integradora

21. Município identifica aumento de casos, barreira de transporte e baixa adesão ao acompanhamento. Uma resposta coerente com o SUS deve:

- A) limitar-se a culpar usuários
- B) analisar dados, território, vigilância e acesso, articulando ações
- C) dispensar planejamento
- D) ignorar rede

Resposta: B. Problemas complexos pedem leitura integrada.

Quadro uniforme de legislação

Norma	Núcleo cobrado	Pegadinha típica
Constituição, arts. 196 a 200	direito à saúde, relevância pública, diretrizes e atribuições	dizer que prevenção exclui assistência
Lei nº 8.080/1990	organização, princípios, determinantes e campo de atuação	reduzir SUS a tratamento
Lei nº 8.142/1990	conselhos, conferências e transferências	trocar periodicidade ou natureza do Conselho
Decreto nº 7.508/2011	regiões, rede, portas, planejamento e RENAME	dizer que APS é única porta
LC nº 141/2012	financiamento, rateio, transparência e fiscalização	contabilizar qualquer despesa
PNAB	APS, território, vínculo e ESF	tratar APS como triagem
Assistência terapêutica	medicamentos, produtos, procedimentos e protocolos	confundir integralidade com oferta sem critérios

Questões legais adicionais

22. A prioridade para atividades preventivas:

- A) elimina assistência
- B) ocorre sem prejuízo dos serviços assistenciais
- C) impede tratamento
- D) pertence somente ao setor privado

Resposta: B.

23. A Lei nº 8.080/1990 reconhece:

- A) determinantes sociais da saúde
- B) somente fatores biológicos
- C) contribuição como requisito universal
- D) exclusão da vigilância

Resposta: A.

24. Conselho de Saúde:

- A) possui caráter permanente e deliberativo
- B) reúne-se apenas quadrienalmente
- C) exclui controle financeiro
- D) substitui gestão

Resposta: A.

25. Região de Saúde:

- A) organiza articulação territorial de ações e serviços
- B) é sinônimo de unidade básica
- C) impede fluxo regional
- D) exclui vigilância

Resposta: A.

26. A LC nº 141/2012:

- A) conecta financiamento a fiscalização e transparência
- B) extingue participação
- C) dispensa planos
- D) limita saúde à internação

Resposta: A.

27. ESF:

- A) é estratégia prioritária de expansão e consolidação da atenção básica
- B) é serviço terciário
- C) elimina território
- D) substitui toda rede

Resposta: A.

Checklist final

- ☐ Sei explicar os arts. 196 a 200 da Constituição.
- ☐ Diferencio universalidade, integralidade e equidade.
- ☐ Conheço objetivos e campos de atuação da Lei nº 8.080/1990.
- ☐ Diferencio conselho e conferência de saúde.
- ☐ Compreendo níveis de atenção e papel coordenador da APS.
- ☐ Explico territorialização, adscrição e ESF.

- ☐ Diferencio as vigilâncias.
- ☐ Diferencio incidência e prevalência.
- ☐ Aplico níveis de prevenção.
- ☐ Entendo acolhimento, determinantes sociais e planejamento.
- ☐ Associo sistemas de informação às suas finalidades.
- ☐ Compreendo a lógica da notificação compulsória.
- ☐ Entendo conservação, registro e cobertura vacinal.
- ☐ Reconheço os três componentes do Pacto pela Saúde.
- ☐ Explico Região de Saúde, rede e portas de entrada.
- ☐ Entendo RENAME, Mapa da Saúde e Comissões Intergestores.
- ☐ Reconheço o campo de atuação da saúde do trabalhador.
- ☐ Explico assistência terapêutica integral, PCDT e RENAME.
- ☐ Relaciono PNAB, território, adscrição e encaminhamento responsável.

Matriz final de revisão por eixo

Eixo	Conceitos que devem estar dominados	Pergunta de autocontrole
Direito à saúde	seguridade, arts. 196 a 200, relevância pública	acesso depende de contribuição?
Lei nº 8.080/1990	objetivos, campo, princípios, determinantes	vigilância e assistência estão integradas?
Lei nº 8.142/1990	conselho, conferência, transferências	conselho é permanente?
Regionalização	região, rede, portas, mapa e comissões	APS é única porta?
PNAB	território, adscrição, vínculo, longitudinalidade	encaminhamento rompe cuidado?
Vigilância	epidemiológica, sanitária, ambiental e trabalhador	qual vigilância responde ao caso?
Epidemiologia	incidência, prevalência e indicadores	a questão fala de casos novos?
Imunização	calendário vigente, conservação e cobertura	há necessidade de busca ativa?
Planejamento	plano, programação, relatório e avaliação	ação está ligada a diagnóstico?
Financiamento	responsabilidade compartilhada, transparência e controle	conselho acompanha prioridades?
Assistência terapêutica	medicamentos, produtos, procedimentos, PCDT e RENAME	oferta segue critérios públicos?

Questões finais de legislação aplicada

28. A iniciativa privada participa do SUS:

- A) em caráter complementar, conforme diretrizes
- B) substituindo obrigatoriamente a rede
- C) sem regulação
- D) apenas na vigilância

Resposta: A.

29. A população adscrita:

- A) favorece vínculo e longitudinalidade
- B) impede toda demanda espontânea
- C) elimina território
- D) exclui equidade

Resposta: A.

30. PCDT:

- A) auxilia padronização clínica e terapêutica
- B) é instrumento de arrecadação
- C) elimina integralidade
- D) trata apenas de transporte

Resposta: A.

31. Uma equipe mantém acompanhamento após encaminhamento especializado. Essa conduta expressa:

- A) fragmentação
- B) coordenação do cuidado
- C) exclusão
- D) centralização

Resposta: B.

Gabarito concentrado da revisão final

Use este quadro somente depois de resolver as questões. Os comentários completos permanecem junto aos exercícios.

Questão	Resposta	Tema
1	B	universalidade
2	A	conferência de saúde
3	B	prevenção secundária
4	A	territorialização
5	B	incidência
6	A	SINASC
7	B	cobertura vacinal
8	A	porta de entrada
9	B	VISAT
10	B	integralidade
11	A	participação social
12	A	vigilância sanitária
13	A	incidência
14	C	prevenção terciária
15	A	Conselho de Saúde
16	A	Conferência de Saúde
17	A	SINASC
18	A	equidade
19	B	descentralização
20	B	acolhimento
21	B	resposta integrada
22	B	prevenção e assistência
23	A	determinantes sociais
24	A	Conselho permanente
25	A	Região de Saúde
26	A	LC nº 141/2012

Questão	Resposta	Tema
27	A	ESF
28	A	participação complementar
29	A	adscrição
30	A	PCDT
31	B	coordenação do cuidado

Bloco final: epidemiologia e vigilâncias

32. Uma investigação sobre aumento de casos novos de doença transmissível pertence mais diretamente à:

- A) vigilância epidemiológica
- B) vigilância patrimonial
- C) previdência social
- D) gestão escolar

Resposta: A. A vigilância epidemiológica detecta mudanças e orienta prevenção e controle.

33. Fiscalização de serviço sujeito a risco sanitário relaciona-se à:

- A) vigilância sanitária
- B) incidência
- C) assistência previdenciária
- D) vigilância patrimonial

Resposta: A.

34. Monitoramento de qualidade do ar e impactos à saúde relaciona-se à:

- A) vigilância ambiental
- B) conferência de saúde
- C) média aritmética
- D) regência nominal

Resposta: A.

35. Investigação de agravos ligados a processos e ambientes de trabalho integra:

- A) VISAT
- B) somente assistência privada
- C) SINASC exclusivamente
- D) atenção terciária apenas

Resposta: A.

36. Prevalência indica:

- A) conjunto de casos existentes em momento ou período
- B) somente casos novos
- C) apenas óbitos
- D) cobertura vacinal

Resposta: A.

37. Incidência é especialmente útil para observar:

- A) aparecimento de casos novos
- B) apenas estoque de medicamentos
- C) reuniões de conselho
- D) internações antigas apenas

Resposta: A.

38. A utilização da epidemiologia no SUS contribui para:

- A) estabelecer prioridades e orientar alocação de recursos
- B) dispensar planejamento
- C) eliminar informação
- D) substituir toda decisão por número isolado

Resposta: A.

39. Uma exposição ambiental não afeta necessariamente todas as pessoas da mesma forma porque:

- A) características individuais e sociais também influenciam risco
- B) território não importa
- C) renda nunca interfere
- D) vigilância ambiental não monitora fatores de risco

Resposta: A.

40. Saúde do trabalhador no SUS:

- A) abrange trabalhadores independentemente da formalidade do vínculo
- B) limita-se a empregados formais
- C) pertence apenas à previdência
- D) exclui prevenção

Resposta: A.

Gabarito do bloco

Questão	Resposta
32	A
33	A
34	A
35	A
36	A
37	A
38	A
39	A
40	A

Fontes oficiais para aprofundamento

- Edital consolidado nº 001/2026 - IDESG
- Constituição Federal compilada - Planalto
- Lei nº 8.080/1990 - Planalto
- Lei nº 8.142/1990 - Planalto
- Política Nacional de Atenção Básica - Ministério da Saúde
- Notificação compulsória - Ministério da Saúde
- Calendário Técnico Nacional de Vacinação - Ministério da Saúde
- Pacto pela Saúde - Ministério da Saúde
- SISAB e e-SUS APS - Ministério da Saúde
- Decreto nº 7.508/2011 - Planalto
- VISAT - Ministério da Saúde
- Lei Complementar nº 141/2012 - Financiamento e fiscalização

Material gerado a partir das apostilas editáveis em Markdown.